EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 68070
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-26 10:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: FELICIA PALACIOS CACERES			RUN	: 5.181.398-7
F.Nac	: 06-11-1926	Edad	: 96 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: SAN PEDRO LILAHUE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-07-21	Fecha Egreso	: 2023-07-26 10:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. A41.9-SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

SEPSIS DE FOCO ABDOMINAL: ITU + GASTROENTERITIS AGUDA (HEMOCULTIVO 20/07/23 + BACILO GRAN NEGATIVO//UROCULTIVO 20/07/23 ENTEROCOCCUS FAECIUM)
AKI PRERRENAL RESUELTA
HTA
DESNUTRICIÓN PROTEICA MODERAD SEVERA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A41.9-SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E46-DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE C/ANTEC DE DM TIPO 2 NIR, HTA, DLP QUE ES DERIVADA EL 20/07/23 DESDE CONSULTORIO DE SAN NICOLAS POR TR. H-E-GEA POR PRESENTAR CUADRO DE 5 DIAS DE EVOLUCION DE CEG, DOLOR ABDOMINAL COLICO, NÁUSEAS, VÓMITOS Y DEPOSICIONES LIQUIDAS POSTERIOR A INGESTA DE PASTEL, CONCOMITANTE TOS Y RUIDOS RESPIRATORIOS. AL INGRESO TAQUICARDICA, TENDENCIA A HIPOTENSION, AFEBRIL, SE LE TOMA ECG QUE MUESTRA AC XFA C/RVR QUE SE MANEJA C/LANATÓSIDO C. SE TOMAN EXÁMENES 20/07/23 GLICEMIA : 97 MG/DL 74 - 106 CREATININA : 4,20 (NOV 2022 0,9), CL CREAT 9,81, RELACION BUN/CREAT 16,2, AMILASA : 38 , F.ALCALINA : 328 , BILI INDIRECTA : 0,21, BILIRRUBINA DIRECTA : 0,79, BILI TOTAL : 1, SGOT : 116 SGPT : 62, GGT : 560 , CK MB : 22 , CK TOTAL: 497 , LIPASA : 41 LACTATO 1 5, % CK-MB : 4,4, PCR 349,1, UREMIA : 146 , BUN 68,2, NA : 132, K : 3,90 , CL : 97, MAU : 107,10 , CREATININURIA : 98,80, RAC : 108,40, TRIGLICÉRIDOS : 163 , BUN: 18, UREMIA : 39 , NA : 141, K : 4,20 CL : 103, HGA: G. BLANCOS 7700, SEG 67%, HCTO : 35,9 , HB : 12,0 PLAQUETAS : 194000, VHS : 67, INR : 1,0, TPO DE PROTROMBINA : 100%, TIEMPO DE PROTROMBINA SEG : 10,7, TSH : 4,796, T4 LIBRE : 0,820, HEMOGLOBINA GLICADA : 5,8, ORINA O : SEMI TURBIO, GLUCOSURIA, : NEGATIVO , PROTEINURIA : 30 MG/DL BILIRRUBINA : 1 MG/DL UROBILINÓGENO : 0,2 MG/DL PH : 5,5 DENSIDAD : 1,020 SANGRE : 25 ERY/UL CUERPOS CETÓNICOS : NEGATIVO NITRITOS : NEGATIVO LEUCOCITOS : 70 LEU/UL SEDIMENTO CELULAS EPITELIALES : ESCASAS HEMATIES : 2 - 5 X CAMPO LEUCOCITOS : 5-10 X CAMPO BACTERIAS : REGULAR CILINDROS : NO SE OBSERVAN CRISTALES : NO SE OBSERVAN POR LO QUE SE DECIDE HOSPITALIZAR. SE INICIA ATB EMPIRICA (CEFTRIAXONA + MTZ) , PACIENTE AFEBRIL DESDE SU INGRESO. HEMOCULTIVO 20/07/23 + BACILO GRAN NEGATIVO + UROCULTIVO 20/07/23 ENTEROCOCCUS FAECIUM, SE REALIZA AJUSTE TTO ANTIBIOTICOTERAPIA. PACIENTE EN MEJORES CONDICIONES GENERALES, DENTRO DE SU CONDICION, HEMODINAMIA ESTABLE AUTOSOSTENIDA, ASINTOMATICA, SIN DISNEA, SIN DIARREA, SIN GLOBO VESICAL, CON PAMETROS INFLAMATORIOS A LA BAJA AUNQUE AUN ALTOS (PCR 349 INGRESO, HOY 169). FAMILIARES INSISTEN EN POSIBILIDAD DE ALTA, SE DECIDE ALTA VIA HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO ABSOLUTO
2. REGIMEN PAPILLA HIPOSODICO + GLUTAPAK 1 AL DIA
3. OMEPRAZOL 20MG 1 COMPRIMIDO/DIA VO
4. CEFTRIAXONA 1 GR 2 FCOS/DIA EV POR 7 DIAS
5. AMOXICILINA 500 MG 2 COMPRIMIDOS C/8 CADA 8 HORAS VO POR 7 DIAS
6. PARACETAMOL 500 MG 2 COMPRIMIDOS C/ 8 HORAS SOS DOLOR O FIEBRE
7. ENALAPRIL 10MG AL DIA
8. EX LABORATORIO CONTROL 28/07/23

EXÁMENES Y RESULTADOS

PieloTC 21/07
Riñon izq pequeño de aspecto atrofico
Nefrolitiasis izq.

CAMILA COLLAO ITURRA
MEDICO TRATANTE
19088566-6

JEFE SERVICIO